

AN daje pseudo-samoocenę — „dam radę kontrolować”

Niska samoocena to grunt, na którym AN zapuszcza korzenie. Kontrola wagi daje pseudo-poczucie wartości. Bez pracy nad samooceną — nawrót pewny.

CZAS: moduł CBT-E enhanced — kilka sesji

REALIZACJA: CBT-E enhanced, gdy niska samoocena = mechanizm centralny

ŹRÓDŁO: Fennell (1999, *Overcoming Low Self-Esteem*); Fairburn (2008, rozdz. 13); Wilfley i in. (2002, IPT-ED)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **pętla niska samoocena ↔ AN** + skąd się bierze niska samoocena (historia rozwojowa, krytyczne komentarze). Sekcja 02 — **siedem kroków pracy** (model Fennell, moduł CBT-E enhanced). Sekcja 03 — **arkusz „budowanie samooceny”**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Niska samoocena (Fennell, 1999) — globalne, stabilne, negatywne przekonanie o sobie: „*jestem niewystarczający/-a*”, „*jestem niewartościowy/-a*”, „*nie zasługuję*”. W AN: **fundament**, na którym buduje się kontrola wagi jako jedyne źródło pseudo-wartości: „*jeśli kontroluję wagę — coś znaczę*”. Fairburn (2008): niska samoocena to jeden z trzech głównych **dodatkowych** mechanizmów podtrzymujących CBT-E enhanced (obok perfekcjonizmu i niskiej tolerancji afektu). **Pętla**: niska samoocena → potrzeba „*czegoś, w czym jestem dobry/-a*” → kontrola wagi → krótkoterminowy boost samooceny → długoterminowo: ciało wyniszczone, relacje opuszczone, samoocena *jeszcze niższa* → potrzeba *jeszcze większej* kontroli. Bez pracy nad samooceną — AN wraca po remisie w niemal każdym przypadku.

01 Pętla niska samoocena ↔ AN

ELEMENT PĘTLI	CO SIĘ DZIEJE
1 · Bazowa niska samoocena	„ <i>Jestem niewystarczający/-a</i> ”. Często wyniesiona z domu (krytyczni rodzice, brak walidacji, porównania z rodzeństwem) lub szkoły (bullying, wykluczenie, niepowodzenia akademickie).
2 · Poszukiwanie „w czym jestem dobry/-a”	Pacjent szuka domeny, w której może coś zrobić dobrze. Często wczesna młodość (12–16 lat), kiedy poczucie własnej wartości jest najmniej stabilne.
3 · Kontrola wagi daje pseudo-sukces	„ <i>Dam radę nie zjeść</i> ”, „ <i>schudłem/-am</i> ”, „ <i>moja waga jest niższa</i> ”. Realne, mierzalne, „ <i>pochwalone</i> ” przez kulturę. Początkowo pacjent czuje się <i>dumny/-a</i> .
4 · Długoterminowo: samoocena jeszcze niższa	AN zabiera relacje, hobby, sukcesy w innych domenach. Pacjent <i>traci</i> obszary, w których mógł budować samoocenę. Pozostaje tylko AN — pętla się zaciska.

AN to pseudo-samoocena, nie prawdziwa. Prawdziwa samoocena = stabilne poczucie wartości niezależnie od osiągnięć. Pseudo = warunkowe („*jeśli kontroluję, jestem OK*”). Pacjent w AN nie ma stabilnej samooceny — ma chwilowe ulgi z każdej restrykcji.

1. **Psychoedukacja** — „Niska samoocena to grunt, na którym AN zapuszcza korzenie. Kontrola wagi daje krótkotrwałe poczucie wartości — ale długoterminowo zabiera Ci źródła prawdziwej samooceny. Bez pracy nad tym — AN będzie wracać”.
2. **Identyfikacja przekonań o sobie** — pacjent zapisuje globalne, negatywne przekonania o sobie: „jestem niewystarczający/-a”, „nikt mnie nie lubi”, „nic mi nie wychodzi”. Bez konfrontacji — tylko nazwanie.
3. **Historia rozwojowa** — „Skąd te przekonania? Kto pierwszy je „nauczył”? Komentarze rodziców, doświadczenia w szkole, porównania, traumy?”. Często ujawnia się rodzina krytyczna, bullying, perfekcjonistyczne środowisko.
4. **Praca z dowodami** — „Co dowodzi przekonania „jestem niewystarczający/-a”? Co je podważa?” Pacjent zbiera dowody przeciwne — często znajduje wiele, ale ich „nie widzi” (negatywne nastawienie poznawcze).
5. **Eksperymenty behawioralne** — pacjent celowo wystawia się na sytuacje, w których przekonanie może być testowane: wyraża potrzeby, prosi o pomoc, próbuje czegoś nowego. Sprawdza, czy rzeczywiście „nikt nie chce mnie znać” lub „nic mi nie wychodzi”.
6. **Budowanie alternatywnej narracji** — pacjent konstruuje bardziej zbalansowane przekonania o sobie: „mam mocne i słabe strony, jak każdy”, „jestem wartościowy/-a niezależnie od osiągnięć”. Powtarzane, ćwiczone.
7. **Rozszerzanie domen samooceny** — równoległe pacjent rozwija inne źródła wartości: relacje, hobby, wkład w społeczność, wartości. Im więcej źródeł, tym mniej zależności od AN (zob. karta pie-chart).

GŁÓWNE NEGATYWNE PRZEKONANIE O SOBIE

— „jestem...”, „nie zasługuję na...”, „nikt mnie...”

SKĄD TO PRZEKONANIE SIĘ WZIĘŁO

— dom, szkoła, rówieśnicy, konkretne sytuacje, komentarze

TRZY DOWODY PRZECIW TEMU PRZEKONANIU

— sytuacje, w których byłem/-am wystarczający/-a, lubiany/-a, sukcesy/-a; nawet drobne

BARDZIEJ ZBALANSOWANE PRZEKONANIE O SOBIE

— „mam mocne i słabe strony, jak każdy”, „jestem wartościowy/-a niezależnie od X”

KONKRETNY EKSPERYMENT BEHAVIORALNY W TYM TYGODNIU

— co zrobię, żeby sprawdzić, czy przekonanie jest prawdziwe

Klucz: niska samoocena to *najtrudniejszy* mechanizm podtrzymujący AN — bo nie znika z restauracją wagi ani z poznawczą pracą nad nadwartościowaniem. Wymaga osobnego modułu, czasu (3–6 miesięcy), i często równoległej pracy systemowej (rodzina, relacje). **Komunikat dla pacjenta:** „nie da się „odzyskać” samooceny w tydzień. To proces. Każdy mały dowód „jestem wystarczający/-a”, każdy kontakt z bliskim, każde małe osiągnięcie poza wagą — buduje grunt. AN dawała Ci pseudo-samoocenę. Pracujemy nad prawdziwą”.

⚠ **Różnicowanie z depresją:** niska samoocena jako mechanizm AN i niska samoocena jako objaw depresji wyglądają podobnie, ale wymagają różnych interwencji. W depresji — antydepresanty mogą pomóc. W AN — niska samoocena nie ustępuje samymi lekami, wymaga pracy poznawczo-behawioralnej i rozszerzania domen samooceny. Często współistnieją — wymaga oceny psychiatrycznej.